УРОК 18. АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ (АИТ). ВИРУС ЭПШЕЙНА-БАРР (ВЭБ).

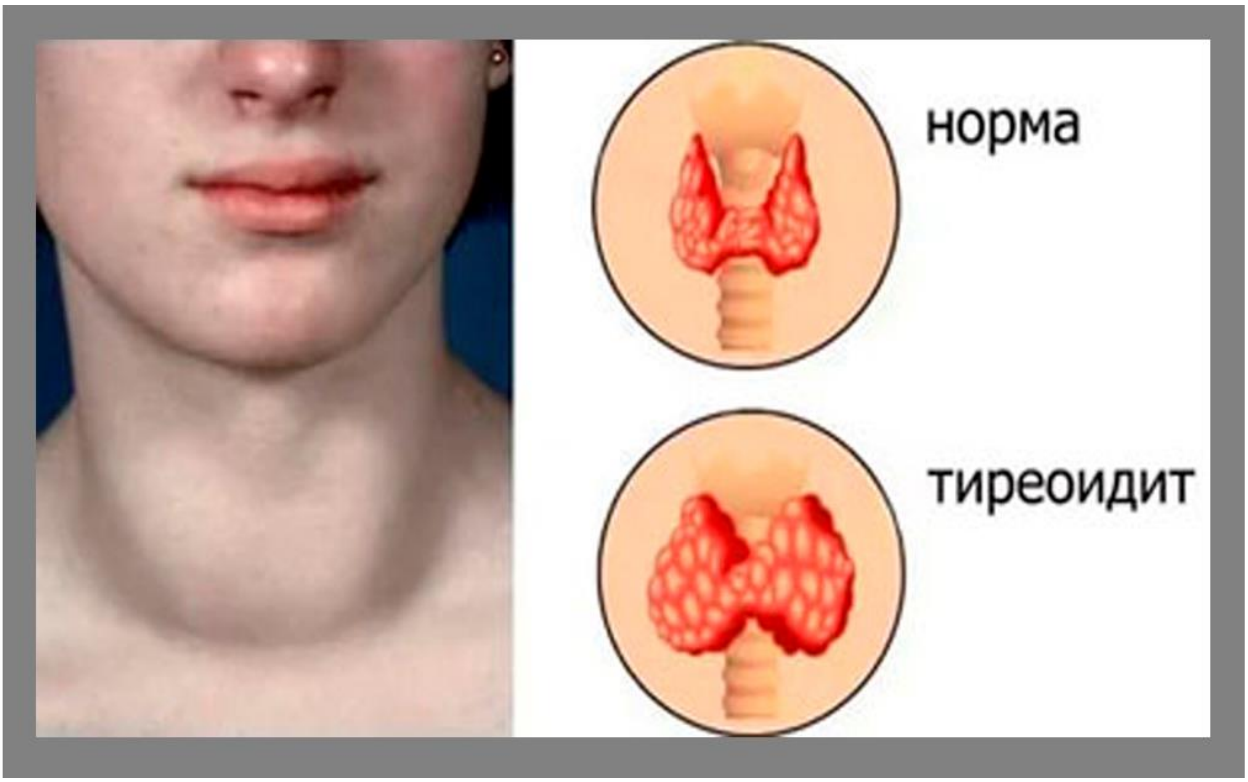
АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ (АИТ)

АИТ – это хроническое аутоиммунное заболевание ЩЖ, при котором происходит постепенно разрушение клеток ЩЖ из-за воздействия на них антител.

Антитела начинают атаковать собственные клетки ЩЖ, а не бактерии или патогены.

Для АИТ характерно безболезненное увеличение щитовидной железы и симптомы гипотиреоза.

ТИРЕОИДИТ ХАШИМОТО – это разновидность АИТ.



Антитела – это белки, которые синтезируются клетками иммунной системы. Основная функция антител – идентификация и нейтрализация чужеродных объектов (бактерий, вирусов, паразитов и пр).

Но в результате мимикрии (подражании), антитела начинают вырабатываться против здоровых тканей собственного организма.

В щитовидной железе наиболее популярными объектами выработки антител являются:

- фермент тиреоидная пероксидаза (тиреопероксидаза или ТПО);
- матрица для синтеза гормонов – тиреоглобулин (ТГ).

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ АИТ

1. ОАК – определяется увеличением количества лимфоцитов.

2. Иммунограмма – в ней определяется количество антител к:
    - тиреоглобулину (АТ-ТГ);
    - тиреопероксидазе (АТ-ТПО).
3. Т3 и Т4 (свободных), ТТГ.
    - высокий ТТГ при Т4 в норме говорит в субклиническом гипотиреозе.
    - высокий ТТГ при низком Т4 – клинический гипотиреоз, т.е. организм уже не справляется с тем, чтобы поддерживать уровень гормонов на постоянном уровне.
4. УЗИ показывает состояние ЩЖ ее уменьшение или увеличение, узлы (кисты), а также гипоэхогенность, которая указывает на АИТ.
5. Тонкоигольная биопсия ЩЖ позволяет выявить большое количество лифмоцитов и другие клетки, характерные для АИТ. Применяется при наличии данных о злокачественном перерождении узлового образования в ЩЖ.

АИТ ЕСТЬ ЕСЛИ:

- повышается уровень циркулирующих антител в ЩЖ (АТ-ТПО, АТ-ТГ);
- на УЗИ обнаружена гипоэхогенность ЩЖ.

! ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ !

1. Если при АИТ назначен левотироксин (L-тироксин, эутирокс), то препараты:

- железа;
- кальция;
- хрома;
- витамины пьем за 3-4 часа до и после приема гормонов.

2. При АИТ ОСТОРОЖНО:

- соя + лен, т.к. эти продукты содержат фитогормоны ИЗОФЛАФОНЫ, которые препятствуют переходу Т4 в Т3. Поэтому веганство или вегетарианство не подходит для тех, у кого есть заболевания ЩЖ;

- многие препараты для облегчения менопаузы содержат изофлавоны сои, поэтому нужно быть внимательным;
- йод нельзя пить больше 150 мкг при наличии антител в ЩЖ, даже если есть его дефицит. Сначала нужно снизить антитела, а затем подключать йодную загрузку;
- искусственные подсластители вредны при АИТ и других аутоиммунных заболеваниях, т.к. они повышают уровень ТТГ и антитела. К ним относится в том числе и стевия. Сахара употребляем в небольшом количестве в виде фруктов и ягод. Можно на некоторое время их исключить;
- при АИТ часто возникает пониженная кислотность желудочного сока, поэтому подключаем при необходимости работу с повышением количества соляной кислоты.

Главная цель лечения любого аутоиммунного заболевания – это не только «спасение» конкретного органа, ткани или железы, но устранение аутоиммунного процесса во всем организме.

Восстановление целостности кишечного барьера – является основой успешного лечения.

Самые разные проблемы, связанные с аутоиммунным состоянием, сопровождаются СДК и СИБР (дисбиозом).

АИТ, болезнь Хашимото, аллергии, экзема, псориаз, диабет, аутические заболевания, депрессия – развитие этих заболеваний берет свое начало в повышенной проницаемости кишки.

Основа профилактики АИЗ заключается в том, чтобы не допустить или как можно скорее обнаружить и вылечить синдром повышенной кишечной проницаемости (СДК), т.к. именно он является предшественником АИЗ.

ДВА СЦЕНАРИЯ РАБОТЫ С АИТ:

СЦЕНАРИЙ 1 – ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИОННУЮ МЕДИЦИНУ.

Традиционная медицина предполагает, что «это не лечится» и делать с этим ничего не нужно. Нужно просто следить, когда ТТГ (тиреотропный) гормоны вырастет выше нормы. И когда это происходит, врач назначает лечение: гормоны пожизненно, со временем лишь увеличивая дозировку. А тем временем, происходит уничтожение ЩЖ своим же аутоиммунитетом (ауто – направленным на себя).

Так сценарий характерен не только для АИТ, это механизм развития практически любого АИЗ.

При таком «лечении» аутоиммунитет начинает уничтожать клетки ЩЖ, которые вырабатывают гормоны и без искусственных гормонов жить становится невозможно. Иногда это может привести к раку ЩЖ и ее удалению.

Нельзя ходить с антителами, как рекомендуют эндокринологи, т.к. они могут начать вырабатываться и против других клеток организма, тем более, что антитела отлично снижаются при работе с питанием и восстановлением работы органов ЖКТ.

СЦЕНАРИЙ 2 – ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАТИВНУЮ НУТРИЦИОЛОГИЮ.

Интегративная нутрициология указывает на то, что лечить нужно не только щитовидную железу, т.к. чаще всего АИТ приводит к гипотиреозу (дефицитному), но и кишечную проницаемость.

В ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ ЭТИОЛОГИЯ (ПРИЧИНЫ) АИЗ НЕ ИЗВЕСТНЫ И ЛЕЧЕНИЯ НЕТ!

НО В ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ АИЗ ИЗВЕСТНЫ.

ДВЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АИТ:

ПРИЧИНА 1 – ХРОНИЧЕСКАЯ ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА:

- вирус Эпшейна-Барр (ВЭБ);
- вирус герпеса;
- цитомегаловирус,
  КОТОРЫЕ ЕСТЬ В 90% ПРАКТИЧЕСКИ У ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА

+ ПАРАЗИТОЗ.

Застой желчи и инфекции в желчных протоках, хронический холестаз, запоры, дисбиоз, СИБР, СВК, СДК, все это и приводит к появлению АИЗ.
70-80% иммунных клеток находятся именно в кишечнике человека, если с ним есть сложности, то иммунитет подавлен и снижен.

Вирусы любят паранхематозные органы и живут в печени, ЩЖ и находятся внутри клеток и при снижении иммунитета начинается реактивация вируса и его деление. Иммунная система начинает на него реагировать и атаковывать свои же клетки, т.к. вирус находится внутри клетки и возникает АИЗ: АИТ, АИГепатит и т.п.

Иммунная система не «сходит с ума», она пытается отреагировать на вирус, который живет внутри клетки и поэтому начинает уничтожать эти клетки.

ПРИЧИНА 2 – МИМИКРИЯ (ПОДРАЖЕНИЕ). Та же самая схема возникает и в результате «путаницы», когда через СДК в кровоток попадают плохо

переработанные крупные молекулы белка (молочных продуктов, глютена – это продукты усваиваются хуже всего у людей). Иммунитет считывает эти молекулы, как чужеродных агентов (из-за их размера) и начинает против них вырабатывать антитела, затем путает их с собственными белковыми клетками и начинает уже уничтожать антителами здоровые ткани.

В традиционной медицине нет препаратов для уничтожения ВЭБ, герпеса, цитомегаловируса. С паразитозом тоже проблемы в лечении.

При АИЗ в кишечнике повышается чувствительность к рядку продуктов, усиливается холестаз, запоры, поэтому при АИЗ применяются АИПротоколы питания и лечения: исключение глютена и молочных продуктов – пожизненно.

При наличии антител в ЩЖ выше 3000 – 5000, также под запретом: алкоголь, бобовые, пасленовые, орехи.

ПРИЧИНЫ АИЗ:

1. Вирусная нагрузка (COVID в том числе);
2. Паразитоз;
3. Сниженный иммунитет;
4. СДК.

АИЗ можно вывести в ремиссию и снизить антитела до нормы.

Поэтому работа с АИЗ начинается с:

1. Безмолочного, безглютенового питания, иногда питания по АИПротоколу.

2. Налаживание работы органов ЖКТ: кислотность желудочного сока, желчеотток, восстановление фаз детоксикации печени, восстановление работы поджелудочной железы и кишечника, работа с воспалением и залечивание слизистой кишечника (урок № 8 про СИБР и СДК), работа с паразитозом.

3. Работа с дефицитами.

4. Работа со стрессом.

5. Режим дня (сон с 22:30).

ПРИМЕР РАБОТЫ С АИТ

АНАЛИЗЫ ДО

Валерьевна Дата рождения: **26.06.1988**

Телефон горячей линии 8-800-700-40-10 звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ

Направил: Ф.И.О. врача не установлены.
Телефон сервисной службы 8-964-906-40-70

Организация: **ООО МКДЦ"Здоровье"(г.Апшеронск ул.Коллективная,31)**

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА)

Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
сТ3 (трийодтиронин свободный)	5,23 пмоль/л	3,8-6
сТ4 (тироксин свободный)	10,56 пмоль/л	7,86-14,41
АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) (технология Beckman Coulter)	183,7 МЕ/мл	<9
ТТГ (тиреотропный гормон)	0,241 мкМЕ/мл	Беременность: Да: Триместр: 1-й триместр: 0,05-3,7 2-й триместр: 0,31-4,35 3-й триместр: 0,41-5,18 Нет: 0,38-5,33
С-Пептид	0,64 нг/мл	0,9-7,1

АТ-ТПО – 183,7 при референсе до 9.

Через 6 месяцев работы с питанием (безмолочное и безглютеновое), работа с СДК (куркумин и берберин) антитела снизились до 51.

Валерьевна Дата рождения: **26.06.1988**

Телефон горячей линии 8-800-700-40-10 звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ
Направил: Ф.И.О. врача не установлены.

Организация: **ООО МКДЦ"Здоровье"(г.Апшеронск ул.Коллективная,31)**
Дата и время взятия биоматериала: 01.10.2021 09:33
Биоматериал: Венозная кровь

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА)

Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
Ферритин	28,1 нг/мл	11-306,8
ТТГ (тиреотропный гормон)	4,289 мкМЕ/мл	Беременность: Да: Триместр: 1-й триместр: 0,05-3,7 2-й триместр: 0,31-4,35 3-й триместр: 0,41-5,18 Нет: 0,38-5,33
сТ4 (тироксин свободный)	10,94 пмоль/л	7,86-14,41
АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) (технология Beckman Coulter)	2,8 МЕ/мл	<4
сТ3 (трийодтиронин свободный)	5,55 пмоль/л	3,8-6
АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) (технология Beckman Coulter)	51,2 МЕ/мл	<9

Динамика работы отличная. Через 3-4 месяца антитела придут в норму. Но такому человеку нужно всегда следить за работой кишечника, не допускать СДК, запоров. А также нужно пропить йод и все кофакторы для щитовидной железы, устранить дефицит железа и ложится спать до 22:30. Нужно далее работать с гормонами ЩЖ и привести их в норму.

ВАЖНО!

ПРИ РАБОТЕ С АИТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В СНИЖЕНИИ АНТИТЕЛ ИМЕЕТ:

- **рацион питания;**
- **режим сна.**

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ ИМЕЕТ ВТОРОСТЕПЕННУЮ РОЛЬ!

ПРИМЕР АНАЛИЗОВ ДО И ПОСЛЕ

АНАЛИЗЫ ДО.

Дата сдачи - 29.10 2021 г.

ТТГ 2,6, АТ-ТПО 313 (до 9).

063-057014

CLPRIME

Татьяна Владимировна

Пол: жен.

Дата рождения: 08.12.1984

Телефон горячей линии 8-800-700-40-10 звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ

Направил: Ф.И.О. врача не установлены.

Дата и время взятия биоматериала: 29.10.2021 09:55

Биоматериал: Венозная кровь

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА)

Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
С-Пептид	2,65 нг/мл	0,9-7,1
сТ4 (тироксин свободный)	10,11 пмоль/л	7,86-14,41
АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) (технология Beckman Coulter)	313,9 МЕ/мл	<9
сТ3 (трийодтиронин свободный)	4,9 пмоль/л	3,8-6
ТТГ (тиреотропный гормон)	2,648 мкМЕ/мл	Беременность: Да: Триместр: 1-й триместр: 0,05-3,7 2-й триместр: 0,31-4,35 3-й триместр: 0,41-5,18 Нет: 0,38-5,33
Ферритин	33,8 нг/мл	11-306,8

Дата сдачи – 24.10.2022 г.

ТТГ – 1,9, АТ-ТПО – 194 (до 5).

Татьяна Владимировна Пол: **жен.**

Дата рождения: **08.12.1984**

Телефон горячей линии 8-800-700-40-10 звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ
Направил: Ф.И.О. врача не установлены.

Дата и время взятия биоматериала: 24.10.2022 09:35
Биоматериал: Венозная кровь

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА)

Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
Витамин B12	625 пг/мл	187-833
Ферритин	55,4 нг/мл	11-306,8
cT3 (трийодтиронин свободный)	4,81 пмоль/л	2,427-6,006
АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе)	194,86 МЕ/мл	<5,61
ТТГ (тиреотропный гормон)	1,9 мкМЕ/мл	0,35-4,94
Фолиевая кислота	9,77 нг/мл	5,9-24,8
Инсулин	7,12 мкМЕ/мл	1,9-23
cT4 (тироксин свободный)	11,7 пмоль/л	7,86-14,41

ДАТА СДАЧИ – 6.03.2023 г.

ТТГ – 1,5, АТ-ТПО – 9,6 (до 5).

№ направления:	1023507777 дата: 2023-03-06	Фамилия:	Девятьярова
ЛПУ:	МО Армавир, Розы Люксембург ул. д.99	Имя:	Татьяна Владимировна
Доктор:	3000	Дата рождения:	1984-12-08
Адрес пациента:		Пол:	женский

Наименование исследования	Результат		Ед. изм.	Нормальные значения
ГОРМОНЫ				
Тиреотропный гормон (ТТГ)	1.5812		мкМЕ/мл	0.3500-4.9400
	Референсные значения для беременных: I триместр - 0,1-2,5 мкМЕ/мл II триместр - 0,2-3 мкМЕ/мл III триместр - 0,3-3 мкМЕ/мл			
Тироксин свободный (Т4 свободный)	13.69		пмоль/л	9.00-19.05
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)	4.50		пмоль/л	2.43-6.01
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО)	9.69	+	МЕ/мл	0.00-5.61
Инсулин	7.80		мкМЕ/мл	2.30-26.40
	Референсные значения согласно Национальному руководству по эндокринологии под редакцией И.М. Дедова, Г.А. Мельниченко (2013 год) - 2,3 - 26,4 мкМЕ/мл. Согласно статье «Sources of variation and establishment of Russian reference intervals for major hormones and tumor markers» Anna Ruzhanskaya, Kiyoshi Ichihara и др., 2021, по результатам многоцентрового исследования определения референтных интервалов для населения РФ, референсные значения для инсулина натощак (для лиц с ИМТ менее 28 кг/м2) составляют 2,0 - 10, 5 мМе/л (мкМЕ/мл)			
Индекс Саго (инсулинорезистетность)	0.62			более 0,33
HOMA (The Homeostatic Model Assessment)	1.67			менее 2,77

ПРИМЕР РАБОТЫ С АИТ (ОТМЕНА ГОРМОНОВ)

Женщина во время беременности узнала, что у нее АИТ. Врач сразу назначил гормоны для щитовидной железы.

ДАТА СДАЧИ: 13.02. 2020 г.

ТТГ 3,7

АТ-ТПО – 227 (до 5)

АТ- ТГ – 30 (до 4)

№ направления:	3650011404	дата:	2020-02-13	Фамилия:	[redacted]ва
ЛПУ:	МО Транспортная			Имя:	Регина Камильевна
В:	3000			Дата рождения:	1991-07-02
Адрес пациента:	г Уфа			Пол:	женский

Наименование исследования	Результат		Ед. изм.	Нормальные значения
ГОРМОНЫ				
Тиреотропный гормон (ТТГ)	**3.7260**		мкМЕ/мл	0.3500 - 4.9400
	Референсные значения для беременных: **I триместр - 0,1-2,5 мкМЕ/мл** **II триместр - 0,2-3 мкМЕ/мл** **III триместр - 0,3-3 мкМЕ/мл**			
Тироксин свободный (Т4 свободный)	**14.01**		пмоль/л	9.00 - 19.05
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)	**5.07**		пмоль/л	2.63 - 5.70
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ)	**30.22**	+	МЕ/мл	0.00 - 4.00
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО)	**227.25**	+	МЕ/мл	0.00 - 5.61
Паратгормон	**39.9**		пг/мл	16.0 - 87.0

ДАТА СДАЧИ: 14.05.2021 г. (женщина после родов, на гормонах щитовидной железы).

ТТГ – 0,004

Т3 и Т4 (вышли за пределы референсов)

АТ-ТПО – 1710 (до 5)

АТ- ТГ – 177 (до 4)

№ направления:	1007825907	дата:	2021-05-14	Фамилия:	[redacted]ва
ЛПУ:	Уфа Выезд			Имя:	Регина Камильевна
В:	3000			Дата рождения:	1991-07-02
Адрес пациента:				Пол:	женский

Наименование исследования	Результат		Ед. изм.	Нормальные значения
ГОРМОНЫ				
Тиреотропный гормон (ТТГ)	**0.0045**	-	мкМЕ/мл	0.3500-4.9400
. **Референсные значения для беременных: I триместр - 0,1-2,5 мкМЕ/мл II триместр - 0,2-3 мкМЕ/мл III триместр - 0,3-3 мкМЕ/мл**				
Тироксин свободный (Т4 свободный)	**26.76**	+	пмоль/л	9.00-19.05
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)	**13.07**	+	пмоль/л	2.63-5.70
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ)	**177.58**	+	МЕ/мл	0.00-4.00
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО)	**1710.28**	+	МЕ/мл	0.00-5.61

ДАТА СДАЧИ: 18.03.2022 г. (женщина сама решила отменить гормоны щитовидной железы и стала работать с причиной появления антител как могла и как знала).

ТТГ – 2,5

Т3 и Т4 (в референсах)

АТ-ТПО – 853 (до 5)

АТ – ТГ – 292 (до 4)

№ направления:	1016261479	дата:	2022-03-18	Фамилия:	[redacted]ва
ЛПУ:	Уфа Выезд			Имя:	Регина Камильевна
В:	3000			Дата рождения:	1991-07-02
Адрес пациента:				Пол:	женский

Наименование исследования	Результат		Ед. изм.	Нормальные значения
ГОРМОНЫ				
Тиреотропный гормон (ТТГ)	**2.5779**		мкМЕ/мл	0.3500-4.9400
. **Референсные значения для беременных: I триместр - 0,1-2,5 мкМЕ/мл II триместр - 0,2-3 мкМЕ/мл III триместр - 0,3-3 мкМЕ/мл**				
Тироксин свободный (Т4 свободный)	**12.22**		пмоль/л	9.00-19.05
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)	**3.43**		пмоль/л	2.63-5.70
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ)	**292.49**	+	МЕ/мл	0.00-4.00
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО)	**853.50**	+	МЕ/мл	0.00-5.61
Паратгормон	**67.8**		пг/мл	16.0-87.0

ДАТА СДАЧИ: 1.02.2023 (через 1 месяц работы с питанием и ЖКТ, после завершения первой ступени программы).

ТТГ – 2,2

Т3 и Т4 (в референсах)

АТ-ТПО – 364 (до 5)

АТ – ТГ – 67 (до 4)

Через 3-4 месяца работы гормоны щитовидной железы придут в норму.

№ направления:	1022159702	дата:	2023-02-01	Фамилия:	Хафизова
ЛПУ:	Уфа Выезд			Имя:	Регина Камильевна
В:	1400004015			Дата рождения:	1991-07-02
Адрес пациента:				Пол:	женский

Наименование исследования	Результат		Ед. изм.	Нормальные значения
ГОРМОНЫ				
Тиреотропный гормон (ТТГ)	**2.2006**		мкМЕ/мл	0.3500-4.9400
	Референсные значения для беременных: **I триместр - 0,1-2,5 мкМЕ/мл** **II триместр - 0,2-3 мкМЕ/мл** **III триместр - 0,3-3 мкМЕ/мл**			
Тироксин свободный (Т4 свободный)	**12.41**		пмоль/л	9.00-19.05
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)	**3.53**		пмоль/л	2.63-5.70
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ)	**67.68**	+	МЕ/мл	0.00-4.00
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО)	**364.70**	+	МЕ/мл	0.00-5.61
Паратгормон	**97.3**	+	пг/мл	16.0-87.0

ВИРУС ЭПШЕЙНА-БАРР (ВЭБ)

ВЭБ известен как вирус герпеса человека 4 типа. Чаще передается через слюну.

ВЭБ является основной причиной инфекционного мононуклеоза, которым чаще болеют дети и подростки. 90% людей инфицировано ВЭБ.

После инфицирования ВЭБ есть три варианта развития событий:

1. ВЭБ протекает бессимптомно при высоком иммунитете.

2. Малосимптомное течение. Инфекция проявляет себя как легкое ОРВИ.

3. Манифестация и выраженная симптоматика инфекционного мононуклеоза.

Главная симптоматика ВЭБ в юном возрасте при первом инфицировании или реактивации вируса уже во взрослом возрасте – это ВЫРАЖЕННАЯ СЛАБОСТЬ, ОБЕССИЛЕННОСТЬ, а также:

- повышение температуры тела;
- увеличение лимфоузлов;
- боль в горле;
- увеличение печени, селезёнки;
- высыпания на коже;
- эмоциональные перепады, панические атаки;
- АИЗ;
- поражение нервной системы, органов пищеварения, щитовидной железы.

Сейчас все чаще исследования превентивной медицины связывают проявление АИЗ с реактивацией в организме ВЭБ, т.к. в основе АИЗ лежит гиперактивация иммунной системы, в следствие которой она начинает атаковывать здоровые ткани организма.

Триггерные факторы АИЗ – различные инфекции, включая ВЭБ.

Причина реактивации вирусной инфекции – сниженный иммунитет.

ЧТО СНИЖАЕТ ИММУНИТЕТ?

- антибиотико- и гормонотерапия;

- питание продуктами, вызывающие воспаление (глютен, молочные продукты, избыток сахара, простых углеводов);

- эндотоксемия – хроническое отравление организма токсичными продуктами жизнедеятельности организма: патогенной флоры при СИБР, паразитозах;

- хронический стресс – ключевая причина дисфункции иммунной системы, которая может активировать ВЭБ.

Удалить ВЭБ из организма, так же как герпес и цитомагаловирус – невозможно, но задача организма при наличии этих вирусов – перевести эти вирусы в фазу интеграции (т.е. сделать так, что вирус «сидел» внутриклеточно и был неактивным из-за сдерживания его иммунитетом).

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЭБ:

1. В 90% случае ВЭБ у человека имеется и нет смысла сдавать анализы, так же, как и на другие типы герпеса и цитомегаловируса.

2. При обострении симптомов можно выявить ДНК ВЭБ в крови или слюне методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

3. Обнаружение IgG методом ПЦР в крови (косвенно может указывать на наличие ВЭБ).

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРИ НАЛИЧИИ ВЭБ, ГЕРПЕСА, ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА – УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА И КИШЕЧНОЙ СТЕНКИ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Что такое АИТ?
2. Что такое антитела?
3. Что больше всего атакуют антитела в ЩЖ?
4. Расскажите про методы диагностики АИТ?
5. Какой фактор на УЗИ ЩЖ может указать на АИТ?
6. Как правильно пить микроэлементы и гормоны?
7. Что нельзя употреблять при АИТ?
8. Как лечат АИТ в традиционной медицине?
9. Как лечат АИТ в интегративной нутрициологии?
10. Какие две главные причины АИТ?
11. Как лечить АИТ?
12. Что такое мимикрия?
13. Что такое ВЭБ?
14. Симптомы инфицирования ВЭБ?
15. Что снижает иммунитет?
16. Как гормонотерапия связана со снижением иммунитета?
17. Можно ли вылечить ВЭБ, цитомегаловирус, герпес?
18. Какой нутрицевтик дезактивирует вирус герпеса?